

La historia clínica es de todos

Ningún profesional, por bueno que sea, está con el paciente las veinticuatro horas. La historia clínica no es un documento: es una **historia que se construye entre todos**, y el paciente es su protagonista.

LOS PRINCIPIOS

Una responsabilidad compartida

- **VII. La continuidad asistencial es una responsabilidad compartida.** Ningún profesional posee toda la información; ninguna disciplina comprende sola toda la realidad del paciente.
- **IX. Cada contacto debe dejar al sistema mejor preparado para el siguiente.** Una visita no termina cuando el profesional se va: termina cuando la información generada permite que el próximo continúe sin empezar de cero.

EN PROFUNDIDAD

Conocimiento distribuido

Cada rol aporta un capítulo. El médico interpreta; la enfermería sigue la evolución; el auxiliar observa el día a día; la familia reconoce la normalidad; el cuidador detecta los cambios; y el paciente le da sentido a todo lo anterior.

Nadie tiene la historia completa, pero todos tienen una parte. La inteligencia del modelo está en integrarlas.

La Historia de Vida genera la Historia Clínica, y la Historia Clínica solo vale si sigue acompañando la Historia de Vida.

EN LA PRÁCTICA

Antes de cerrar un contacto

Preguntate: ¿qué dejo registrado para que el próximo no empiece de cero? La continuidad no depende de que nunca cambie el profesional, sino de que nunca se pierda el conocimiento.

LA IDEA PARA LLEVARTE

Si mañana cambia el médico pero el conocimiento del paciente permanece, el paciente sigue teniendo continuidad. Eso es lo que cuidamos.